

Derrames de sangre y fluidos y exposición accidental

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Controlar contaminación y exposición sin introducir riesgo por cortopunzantes o mezcla de químicos.

2. Alcance y condiciones de uso

Derrames reales de fluidos y productos químicos; estos últimos siguen su ficha de seguridad, sin tratarlos automáticamente como sangre.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Suspender uso del área, retirar usuarios y delimitar el derrame

Suspender uso del área, retirar usuarios y delimitar el derrame. Identificar tipo de fluido y presencia de vidrio o agujas; solicitar apoyo y protección según exposición.

2. Realizar manos y colocar barreras adecuadas

Realizar manos y colocar barreras adecuadas. Recoger cortopunzantes con instrumento apropiado hacia contenedor rígido, nunca con manos ni escoba de uso general.

3. Absorber y retirar material orgánico con método seguro, disponer en residuo correspondiente

Absorber y retirar material orgánico con método seguro, disponer en residuo correspondiente y limpiar con detergente compatible antes de desinfectar.

4. Aplicar desinfectante apto para el evento según etiqueta, concentración y contacto; no improvisar

Aplicar desinfectante apto para el evento según etiqueta, concentración y contacto; no improvisar porcentajes ni mezclar con otro producto. En derrame químico seguir la ficha y no neutralizar sin indicación competente.

5. Si hubo exposición de piel, mucosa o lesión, realizar medidas iniciales seguras y activar

Si hubo exposición de piel, mucosa o lesión, realizar medidas iniciales seguras y activar atención urgente y ruta ocupacional. La decisión de profilaxis o seguimiento es clínica y no se sustituye por esta plantilla.

6. Verificar área, secado y residuos antes de liberar

Verificar área, secado y residuos antes de liberar. Registrar producto, evento, atención, causa y medida para prevenir repetición y reponer kit.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Atención inmediata.

Protección y producto según riesgo.

Kit disponible con fichas y reposición.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Fecha área y sustancia	
Extensión y objeto cortante	
Protección	
Recogida y limpieza	
Desinfectante y contacto	
Residuo y contención	
Persona expuesta	
Atención y reporte	
Liberación	
Reposición	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Referencia técnica de infección

OMS, Hand hygiene in outpatient and home-based care (2012), estrategia multimodal y cinco momentos. Referencia técnica para adaptación ambulatoria, no reglamento colombiano ni sustituto de etiqueta o fabricante.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241503372>

Residuos

Resolución 591 de 2024, artículos 1-4 y manual anexo; Decreto 780 de 2016, gestión de residuos en atención en salud. Diagnóstico, cantidades, rutas y soportes del gestor deben ser reales.

https://minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No%20591%20de%202024.pdf

Trabajo y salud ocupacional

Decreto 1732 de 2015, CC SST, Decreto 1732 de 2015, CC SST, Decreto 1732 de 2015, CC SST, Decreto 1732 de 2015, CC SST

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576